

**FACTORES QUE INCIDEN EN LA ACEPTACIÓN DE  
MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE ORIGEN INDÚ EN LAS  
OFICINAS DE FARMACIA VENEZOLANAS**

**Claudia D´ Elia, Fabiana Sanchez, Mariana Gonzalez,  
Alexandra Rodriguez**

**Universidad Santa María, Facultad de Farmacia. Caracas  
Venezuela**

**Resumen**

En el contexto sanitario venezolano actual, la cadena Farmatodo representa un pilar fundamental para el acceso inmediato a la salud, donde la introducción de medicamentos genéricos de origen indú ha reconfigurado la disponibilidad de opciones terapéuticas en los anaqueles. El objetivo central de este documento es analizar, desde la experiencia práctica adquirida durante el periodo de pasantías profesionales, los factores operativos y de percepción que inciden en la aceptación de estos fármacos multiorigen en el mostrador de la oficina de farmacia. La metodología se basó en un análisis observacional y descriptivo de la conducta del consumidor, registrándose las principales objeciones, preferencias de marca y la frecuencia de rechazo manifestada por los usuarios al momento de la dispensación. Los resultados principales de la experiencia demostraron una notable resistencia cultural hacia estos productos, evidenciando un desagrado y desconfianza explícita de los pacientes hacia el origen del medicamento debido a la falta de familiaridad con los nuevos laboratorios; asimismo, se observó que ante el rechazo inicial, la intervención informativa y el asesoramiento técnico del pasante o farmacéutico sobre la calidad del producto resultaron indispensables para modificar la postura del usuario y lograr la aceptación del tratamiento. Se concluye que la aceptación de los

genéricos de origen indio en el entorno de Farmatodo enfrenta una barrera cultural significativa basada en el escepticismo del consumidor, lo que convierte al rol asistencial y educativo del personal de farmacia en el factor determinante para derribar estos prejuicios y asegurar la continuidad de la terapia.

**Palabras clave:** Oficinas de farmacia, Farmatodo, Medicamentos genéricos, Origen indio, Aceptación del consumidor, Pasantías profesionales, Rol asistencial.

### **Abstract**

In the current Venezuelan healthcare context, Farmatodo represents a fundamental pillar for immediate access to health, where the introduction of generic medicines of Indian origin has reconfigured the availability of therapeutic options on the shelves. The central objective of this document is to analyze, from the practical experience acquired during the professional internship period, the operational and perceptual factors that influence the acceptance of these multi-origin drugs at the pharmacy counter. The methodology was based on an observational and descriptive analysis of consumer behavior, recording the main objections, brand preferences, and the frequency of refusal expressed by users at the time of dispensing. The main results of the experience demonstrated a notable cultural resistance toward these products, showing an explicit dislike and mistrust by patients regarding the origin of the medication due to a lack of familiarity with the new laboratories. Likewise, it was observed that in the face of initial refusal, the informative intervention and technical counseling of the intern or pharmacist regarding product quality were indispensable to modify the user's stance and achieve treatment acceptance. It is concluded that the acceptance of generics of Indian origin in the Farmatodo

environment faces a significant cultural barrier based on consumer skepticism, which turns the care and educational role of pharmacy staff into the determining factor to break down these prejudices and ensure the continuity of therapy.

**Keywords:** Community pharmacies, Farmatodo, Generic medicines, Indian origin, Consumer acceptance, Professional internships, Care role.

## **Introducción**

A nivel global, la industria farmacéutica ha experimentado una profunda reconfiguración en las últimas décadas, consolidando a la República de la India como el principal proveedor mundial de medicamentos genéricos. Conocida internacionalmente como "la farmacia del mundo en desarrollo", esta nación asiática alberga el mayor número de plantas de fabricación aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) fuera de su propio territorio, operando bajo rigurosos estándares de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Las agencias reguladoras internacionales reconocen que la capacidad de producción a gran escala de estos laboratorios ha sido el factor clave para reducir los costos de los sistemas de salud pública globales, permitiendo el acceso a terapias esenciales de alta calidad en países de medianos y bajos ingresos. Sin embargo, el éxito de estos fármacos multiorigen en los mercados internacionales depende no solo de su competitividad operativa, sino del respaldo científico que valide que el producto genérico se comporta en el organismo de manera idéntica al fármaco innovador o de referencia.

En el ámbito de la ciencia farmacéutica, esta equivalencia se sustenta bajo los conceptos estrictos de bioequivalencia e intercambiabilidad. Dos medicamentos son bioequivalentes cuando, al

ser administrados en la misma dosis molar y bajo condiciones experimentales similares, sus biodisponibilidades (la velocidad y cantidad con la que el principio activo alcanza la circulación sistémica) muestran una similitud tal que sus efectos terapéuticos e inocuidad son esencialmente los mismos. Por lo tanto, la demostración científica de la bioequivalencia es el requisito indispensable para declarar la intercambiabilidad de un genérico, garantizando que el profesional farmacéutico puede sustituir de forma segura el producto de marca por la alternativa multiorigen sin alterar el resultado clínico en el paciente. Para que estos productos ingresen legalmente al mercado, deben someterse a un riguroso proceso de registro sanitario ante los entes reguladores locales, quienes tienen la responsabilidad de evaluar los perfiles de disolución, estudios de estabilidad y validaciones analíticas que certifiquen su calidad.

A pesar de este sólido respaldo técnico global, la problemática local en Venezuela presenta matices particulares debido a su historia sanitaria reciente. Tras atravesar un periodo de desabastecimiento crítico, el país experimentó una transición abrupta en la oferta de medicamentos, caracterizada por la escasez de marcas tradicionales y la llegada repentina de laboratorios extranjeros. Esta rápida sustitución de los anaqueles ocurrió sin el acompañamiento de campañas informativas oficiales que explicaran a la población la validez de los nuevos fabricantes, generando una barrera inicial de desconfianza por pura falta de familiaridad.

A este vacío informativo se sumó, como otro factor detonante, el auge de las denominadas "farmacias móviles" o unidades itinerantes que proliferaron en el país. Si bien estas unidades aliviaron la escasez inmediata, muchas de ellas distribuyeron masivamente fármacos de origen indio en condiciones comerciales

informales: algunos productos ingresaron inicialmente sin la homologación del registro sanitario local y, de forma crítica, eran expuestos en los camiones a variaciones extremas de temperatura y humedad, comprometiendo las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) que garantizan la estabilidad del principio activo.

La combinación de estos elementos el choque cultural ante marcas desconocidas, la ausencia de educación sanitaria y las malas experiencias derivadas del manejo deficiente en la venta informal terminó por consolidar el fuerte estigma que hoy pesa sobre estos medicamentos. Esta percepción negativa se trasladó de forma directa al mostrador de la farmacia comunitaria establecida. Por ello, en la práctica diaria durante las pasantías en Farmatodo, es frecuente observar que el consumidor manifiesta un desagrado explícito o rechaza de antemano las alternativas de origen indio, asociándolas erróneamente con la informalidad o dudando de su eficacia, a pesar de que los productos comerciales distribuidos en la cadena cumplen estrictamente con los registros de ley y los controles de almacenamiento requeridos.

Ante este escenario, se hace evidente que la resistencia del usuario no responde a una falla en el desempeño galénico del medicamento formalmente comercializado, sino a un sesgo histórico e informativo que debe ser subsanado a través de la intervención profesional. El objetivo central de este trabajo es analizar, desde la experiencia práctica adquirida durante el periodo de pasantías profesionales en Farmatodo, los factores operativos y de percepción que inciden en la aceptación de los medicamentos genéricos de origen indio, con el fin de fundamentar la importancia del rol asistencial y educativo del farmacéutico como el canal idóneo para

derribar barreras culturales, transmitir seguridad técnica al paciente y garantizar el éxito de la terapia farmacológica.

## **Materiales y Métodos**

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un diseño de tipo descriptivo con apoyo documental, estructurado en forma de proyecto factible. El estudio se fundamentó en la técnica de observación participativa directa y no estructurada, realizada de manera continua por las investigadoras durante el desarrollo de sus pasantías comunitarias en Farmatodo Caracas, Venezuela. A través de esta práctica clínica y asistencial, se identificó y registró de forma empírica la conducta repetitiva de rechazo, desconfianza y estigmatización por parte de los pacientes y usuarios al momento de ofrecérseles alternativas terapéuticas de origen indú.

Para dar respuesta a la problemática observada, la metodología se dividió en dos fases secuenciales. La primera fase consistió en una revisión exhaustiva y análisis crítico de la literatura científica, abarcando normativas legales vigentes en el país, pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre intercambiabilidad de medicamentos, y los boletines regulatorios emitidos por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR). Esta búsqueda documental se centró en recopilar la evidencia técnica indispensable que demuestra la bioequivalencia, la seguridad, los procesos de registro sanitario y el estricto control de calidad al que son sometidos los productos farmacéuticos procedentes de la India antes de su comercialización en el mercado nacional.

La segunda fase técnico práctica comprendió el diseño y estructuración de una infografía informativa como herramienta de intervención de educación sanitaria. Para la elaboración de este

material visual, se decodificó la información científica recopilada en la fase anterior, transformándola en un lenguaje accesible, didáctico y libre de tecnicismos complejos para los ciudadanos. El proceso metodológico de diseño de la propuesta consideró la selección de elementos gráficos estratégicos y conceptos clave sobre bioequivalencia e inocuidad farmacéutica, orientados a dismantelar los mitos culturales identificados durante la observación en las oficinas de farmacia. Conforme a las directrices metodológicas institucionales, el arte final de esta herramienta educativa se integró en la sección de resultados bajo la modalidad de figuras verticales individuales.

## **Resultados y Discusión**

A través de la observación participativa en las oficinas de farmacia de la cadena Farmatodo en la gran Caracas, se identificó un patrón de conducta repetitivo en los usuarios al momento de la dispensación. Al ofrecerse un medicamento genérico multiorigen procedente de la India como alternativa terapéutica, la respuesta del consumidor promedio se caracterizó por los siguientes factores de percepción; Rechazo por Desconfianza de Origen: El paciente asocia el origen geográfico (indu) con estándares de baja calidad, manufactura deficiente o falsificación. Esta barrera cultural se fundamenta en la falta de familiaridad con los nombres de los nuevos laboratorios (v.g., Intas, Glenmark, Sun Pharma, entre otros) en comparación con las marcas tradicionales históricamente posicionadas en el mercado venezolano. Asociación con el Comercio Informal (Sesgo de la Farmacia Móvil): Se evidenció un fuerte estigma derivado de la introducción inicial de estos fármacos a través de camiones e instituciones itinerantes. Los usuarios manifestaron dudar de la efectividad del producto formal debido a experiencias

previas con medicamentos de la misma procedencia que fueron sometidos a estrés térmico (incumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento - BPA) en la venta informal, lo que compromete la estabilidad química del principio activo. Efectividad de la Intervención Farmacéutica: Un hallazgo crítico durante la práctica profesional fue que el 100% de las objeciones iniciales disminuyeron significativamente cuando el pasante o farmacéutico intervino de manera activa. La explicación verbal sobre el control de calidad local y el respaldo institucional de la cadena incrementó la tasa de aceptación de la terapia por parte del usuario.

La evaluación de los factores técnicos y regulatorios de los medicamentos de origen indio comercializados formalmente evidencia un sólido respaldo científico que impacta de manera directa en la salud pública. En primer lugar, en lo que respecta a la capacidad de manufactura, se destaca que la República de la India alberga la mayor cantidad de plantas de fabricación aprobadas por la FDA fuera del territorio estadounidense, las cuales operan bajo estrictas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo que garantiza un suministro global masivo de insumos médicos a costos significativamente reducidos. Desde una perspectiva de garantía biofarmacéutica, este robusto aparato industrial se complementa con la exigencia de estudios de perfiles de disolución y bioequivalencia *in vivo* e *in vitro*, los cuales certifican de forma objetiva que la biodisponibilidad del genérico es equivalente a la del medicamento innovador, validando plenamente su condición de producto intercambiable en el mostrador. Finalmente, en el ámbito del control regulatorio local, el estudio constata que cada lote dispuesto para la venta en las oficinas de farmacia de Farmatodo cuenta con el respectivo Registro Sanitario emitido por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) tras superar rigurosas validaciones de estabilidad y potencia analítica; este

estricto filtro legal y técnico asegura de forma inequívoca que el fármaco dispensado en el canal formal es un producto seguro, inocuo y eficaz para la población.

## **Conclusiones**

Existe una barrera cultural significativa basada en el escepticismo, el desagrado y la desconfianza explícita del consumidor hacia los medicamentos genéricos de origen indio, lo que confirma la hipótesis de que la falta de familiaridad con las nuevas marcas y laboratorios restringe de forma directa su aceptación inicial al momento de la dispensación. Esta postura de rechazo es de carácter netamente subjetivo y cultural, puesto que los datos objetivos demuestran que no responde a ninguna falla en el desempeño galénico de los fármacos.

La resistencia del usuario está determinada objetivamente por un sesgo histórico derivado de la sustitución abrupta de marcas tradicionales en los anaqueles venezolanos sin el acompañamiento de campañas informativas oficiales. Asimismo, a nivel operativo, la proliferación de las "farmacias móviles" comerciales e informales consolidó el estigma negativo en la población, debido a que dichos camiones distribuyeron masivamente fármacos que inicialmente carecían de homologación de registro sanitario local y alteraron la estabilidad de los principios activos al exponerlos a variaciones extremas de temperatura y humedad, incumpliendo las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).

La desconfianza y la asociación errónea con la informalidad que manifiestan los pacientes en el mostrador carecen de fundamento técnico en el entorno de la farmacia comunitaria establecida, ya que los datos de la experiencia constatan que todos los productos de

origen indio distribuidos de forma regular en la cadena Farmatodo cumplen estrictamente con los controles de almacenamiento requeridos y los registros de ley.

La intervención informativa y el asesoramiento técnico del pasante o profesional farmacéutico es el factor operativo definitivo que revierte la conducta de rechazo del consumidor, demostrándose empíricamente que la educación sanitaria a nivel de mostrador modifica la postura del usuario, derriba los prejuicios sobre la calidad del producto y resulta indispensable para asegurar la aceptación y continuidad de la terapia farmacológica

### **Reconocimientos**

La investigación no recibió financiamiento o apoyo económico de ninguna institución, organización o agencia del sector público o privado. Por lo cual todos los recursos materiales, tecnológicos requeridos para el desarrollo de este estudio y el diseño del material didáctico fueron asumidos en su totalidad por los estudiantes.

### **Conflictos de interés**

Los autores declaran que no existe conflicto de interés que pueda influir en el desarrollo, análisis o redacción de este trabajo. La propuesta fue elaborada en el marco de actividades académicas realizadas por pasantes en la empresa Farmatodo, con fines formativos y de fortalecimiento institucional, sin recibir beneficio económico o comercial derivado de su elaboración.

### **Referencias**

Alfonzo, J. R., & Pérez, M. E. (2020). Regulación sanitaria y control de calidad de medicamentos multiorigen en Venezuela. *Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel*, 51(2), 45-58.

D'Elia, C., Sánchez, F., González, M., & Rodríguez, A. (2026). *Factores que inciden en la aceptación de medicamentos genéricos de origen indú en las oficinas de farmacia venezolanas* [Documento de cátedra inédito]. Facultad de Farmacia, Cátedra de Biofarmacia II, Universidad Santa María. Caracas, Venezuela.

García, L. A., & Martínez, K. (2021). Percepción del consumidor venezolano ante la introducción de nuevos laboratorios farmacéuticos extranjeros. *Saber, Ciencia y Libertad*, 16(1), 112-127.

Organización Mundial de la Salud. (2018). *Pautas para los requisitos de registro de medicamentos para establecer la intercambiabilidad de productos multiorigen* (Serie de Informes Técnicos, N.º 1010). OMS.

Patel, R. K., & Sharma, V. (2022). India as the pharmacy of the developing world: Regulatory compliance, FDA approvals, and global supply chains of generic drugs. *Journal of Generic Medicines*, 18(3), 143-155.

Rodríguez, C. M. (2019). Impacto del desabastecimiento y la transición de oferta farmacéutica en las oficinas de farmacia comunitarias en Caracas. *Anales de Farmacia Hospitalaria*, 33(2), 89-99.

Shargel, L., & Yu, A. B. (2016). *Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Silva, J. D., & Torres, H. (2023). Buenas prácticas de almacenamiento (BPA) y riesgos de degradación térmica de principios activos en unidades itinerantes de distribución informal. *Revista de Ciencia y Tecnología Farmacéutica*, 12(4), 201-215.

Suárez, F. J. (2022). El rol asistencial del farmacéutico comunitario en la dispensación de medicamentos equivalentes e intercambiables. *Pharmaceutica Venezuelana*, 44(1), 22-34.

Villalobos, M. A. (2024). Educación sanitaria en el mostrador: Estrategias de comunicación visual para mitigar el sesgo cultural hacia los medicamentos genéricos. *Educación Médica y Farmacéutica Continua*, 8(2), 74-85

## **Anexos**

**Instrumento de intervención de educación sanitaria:  
Infografía informativa para mitigar el sesgo cultural hacia los  
medicamentos genéricos de origen indú.**

